HELP_Organi_P29 — Groupe F — Lots 247, 248, 217 à 226 — 19 questions

Questionnaire de recherche médicale pour l'encyclopédie PROFILES (examen fédéral suisse). Paquet 29 sur 30.

Consignes

1. Tu réponds de façon sourcée, jamais de mémoire. Sources suisses d'abord (OFSP, Swissmedic, AIPS sur swissmedicinfo.ch, Tox Info Suisse, Fedlex, ASSM, FMH, sociétés suisses), puis européennes (ESC, ERS, ERC, EASL, ESCMID, ESE, EULAR, EAACI, KDIGO, EMA). Jamais de recommandation exclusivement américaine.
2. Pour chaque question : recommandation suisse en vigueur (société ou autorité, titre, année, URL) ; version la plus récente comparée à la version citée dans le « Contexte », avec les différences ; informations, doses, posologies, voies et adaptations (rein, foie, enfant, grossesse) selon l'AIPS, avec le numéro d'autorisation Swissmedic ; à défaut de source suisse, la recommandation européenne la plus récente.
3. Chaque réponse a sa propre source et son propre extrait mot pour mot, avec URL et date de consultation. Les formules « idem », « voir question X » ou une source recopiée sans extrait propre sont interdites.
4. Si aucune source fiable n'existe, écris « donnée non trouvée dans les sources consultées » et liste les sources consultées. N'invente jamais.
5. Au début, écris le nombre de questions reçues dans ce paquet. À la fin, rends exactement le même nombre de réponses, avec leurs numéros.
6. Fais ensuite auditer ce paquet par un agent distinct, en raisonnement élevé : URL existante, extrait présent dans la source, source suisse ou européenne la plus récente, dose conforme à l'AIPS. Il corrige ou marque « donnée non trouvée ». Il n'invente jamais.
7. Rends les réponses dans un Google Doc du dossier HELP nommé comme ce paquet, suivi de « _REPONSES ». Écris en français, en phrases verbales courtes.

Questions

F-135 — Moyenne — LOT 226 · SSP O7.4

Emplacement : evidence.json (LOT_226, dossier de preuves ; fichiers HTML du cours non encore produits) › not_found n° 11 (facteurs psychosociaux du risque cardiovasculaire)

Contexte : Les lignes directrices ESC 2021 de prévention (facteurs psychosociaux) ne sont pas lues en texte intégral.

Question : Quelles recommandations (classe et niveau) l'ESC 2021 de prévention cardiovasculaire, ou une version plus récente, formule-t-elle sur le dépistage et la prise en charge des facteurs psychosociaux (stress, dépression, isolement) ? Citez la recommandation suisse en vigueur (société savante ou autorité : titre, année, URL). Comparez sa version la plus récente avec celle utilisée dans le cours et listez les différences. Précisez les doses éventuelles selon l'information professionnelle suisse (AIPS). À défaut de source suisse, citez la recommandation européenne la plus récente.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

F-001 — Haute — LOT 247 · SSP O7.25

Emplacement : LOT_247_Appel_A_V5_Ultra_Pedagogique_Plan_et_Liste.html ; LOT_247_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_1_DX.1_a_DX.2.html › Bloc 1 › point 11.B › tableau des moyens pharmacologiques (olaparib) ; Partie 1 › DX.1 BRCA › point 11.B

Contexte : Le cours cite Lynparza® 300 mg 2×/j, ClCr 31–50 mL/min : 200 mg 2×/j, ≤ 30 mL/min : non recommandé ; adaptation hépatique « donnée non trouvée ».

Question : Quelle est l'adaptation de dose de l'olaparib (Lynparza®) en insuffisance hépatique légère, modérée et sévère selon l'IP suisse, et quelles sont les indications suisses actuelles liées à un variant germinal BRCA ? Donnez la posologie selon l'information professionnelle suisse en vigueur (AIPS, swissmedicinfo.ch : spécialité ®, titulaire, date de révision, URL) : dose, voie, rythme, durée et adaptations rénale, hépatique, pédiatrique, grossesse et allaitement. Comparez avec la version citée dans le cours et signalez toute différence. À défaut d'IP suisse, citez la recommandation européenne la plus récente (titre, année, URL).

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

F-002 — Haute — LOT 247 · SSP O7.25

Emplacement : LOT_247_Appel_A_V5_Ultra_Pedagogique_Plan_et_Liste.html ; LOT_247_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_1_DX.1_a_DX.2.html › Bloc 1 › point 11.B › tamoxifène ; Partie 1 › DX.1 › point 11.B et point 9 (grossesse)

Contexte : Le cours cite Tamoxifen Farmos 20 mg/j 5 ans en adjuvant ; la chimioprévention n'est pas mentionnée dans l'IP suisse (NICE : 5 ans chez la préménopausée à haut risque) ; adaptation rénale/hépatique « donnée non trouvée ».

Question : Le tamoxifène possède-t-il en Suisse une indication de chimioprévention chez la femme à haut risque (BRCA ou risque familial), quelle est la position suisse ou européenne (ESMO 2023 HBOC) sur cette chimioprévention, et quelles adaptations rénales et hépatiques prévoit l'IP suisse ? Donnez la posologie selon l'information professionnelle suisse en vigueur (AIPS, swissmedicinfo.ch : spécialité ®, titulaire, date de révision, URL) : dose, voie, rythme, durée et adaptations rénale, hépatique, pédiatrique, grossesse et allaitement. Comparez avec la version citée dans le cours et signalez toute différence. À défaut d'IP suisse, citez la recommandation européenne la plus récente (titre, année, URL).

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

F-003 — Haute — LOT 247 · SSP O7.25

Emplacement : LOT_247_Appel_A_V5_Ultra_Pedagogique_Plan_et_Liste.html ; LOT_247_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_1_DX.1_a_DX.2.html › Bloc 1 › point 11.B › acide acétylsalicylique ; Partie 1 › DX.2 Lynch › point 11.B et 11.C

Contexte : Le cours cite Aspirine Cardio® 100/300 (indications suisses cardiovasculaires seulement), CAPP2 600 mg/j, EHTG au minimum 75–100 mg/j ; adaptation, durée et calendrier biologique « donnée non trouvée ».

Question : Quelle dose, quelle durée et quelle surveillance de l'aspirine en chimioprévention du syndrome de Lynch recommandent les sources européennes les plus récentes (EHTG/ESCP, ESMO, résultats CAPP3 s'ils sont publiés), et l'usage reste-t-il hors indication en Suisse ? Citez la recommandation suisse en vigueur (société savante ou autorité : titre, année, URL). Comparez sa version la plus récente avec celle utilisée dans le cours et listez les différences. Précisez les doses éventuelles selon l'information professionnelle suisse (AIPS). À défaut de source suisse, citez la recommandation européenne la plus récente.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

F-004 — Haute — LOT 247 · SSP O7.25

Emplacement : LOT_247_Appel_A_V5_Ultra_Pedagogique_Plan_et_Liste.html ; LOT_247_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_2_DX.3_a_DX.5.html › Bloc 1 › point 11.B › statines, ézétimibe, anti-PCSK9, inclisiran ; Partie 2 › DX.4 HF › point 11.B

Contexte : Le cours cite Sortis® 10–80 mg, Ezetrol® 10 mg, Repatha® 140 mg/2 sem ou 420 mg/mois, Leqvio® 284 mg J0/M3/6 mois ; adaptations rénale/hépatique « donnée non trouvée » ; posologies suisses de rosuvastatine, bempédoate et évinacumab non trouvées.

Question : Quelles adaptations rénales et hépatiques prévoient les IP suisses de l'atorvastatine, de l'ézétimibe, de l'évolocumab et de l'inclisiran, et quelles spécialités et posologies suisses existent pour la rosuvastatine, l'acide bempédoïque (seul ou associé) et l'évinacumab dans l'hypercholestérolémie familiale hétéro- et homozygote ? Donnez la posologie selon l'information professionnelle suisse en vigueur (AIPS, swissmedicinfo.ch : spécialité ®, titulaire, date de révision, URL) : dose, voie, rythme, durée et adaptations rénale, hépatique, pédiatrique, grossesse et allaitement. Comparez avec la version citée dans le cours et signalez toute différence. À défaut d'IP suisse, citez la recommandation européenne la plus récente (titre, année, URL).

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

F-005 — Haute — LOT 247 · SSP O7.25

Emplacement : LOT_247_Appel_A_V5_Ultra_Pedagogique_Plan_et_Liste.html ; LOT_247_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_2_DX.3_a_DX.5.html › Bloc 1 › fenêtre 2.2 (remboursement) et piège d'examen ; tableau comparatif DX.4 ; Partie 2 › fenêtre 4.1 et fenêtre exigences d'autorisation

Contexte : Le cours écrit que le test génétique de l'HF n'était pas remboursé en 2022 [S32] ; situation 2026 et positions tarifaires de la Liste des analyses (LA) « donnée non trouvée ». OPAS art. 12d let. f est cité pour les cancers héréditaires.

Question : La Liste des analyses (LA, annexe 3 OPAS) en vigueur en 2026 rembourse-t-elle le test génétique de l'hypercholestérolémie familiale, et quelles positions du chapitre génétique (cancers héréditaires, HF, hémochromatose, CFTR, FMR1, HTT, pharmacogénétique DPYD/HLA-B*57:01) existent, avec leurs conditions de prescription ? Citez le texte en vigueur (Fedlex : RS, article, alinéa et lettre exacts, état de consolidation, URL) ou l'entrée Swissmedic/AIPS ou la décision officielle, avec date. Comparez avec la version citée dans le cours et signalez tout changement.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

F-007 — Haute — LOT 247 · SSP O7.25

Emplacement : LOT_247_Appel_A_V5_Ultra_Pedagogique_Plan_et_Liste.html ; LOT_247_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_3_DX.6_a_DX.7.html › Bloc 1 › point 11.B › bêtabloquant du QT long ; Partie 3 › DX.7 › point 11.B

Contexte : Le cours cite Inderal® (posologie orientée HTA : 80 mg 2×/j, 160–320 mg/j ; enfant 2–3 mg/kg/j) ; spécialité suisse du nadolol et posologie de la mexilétine (QT long de type 3) non trouvées. Question pendante du HELP LOT_247 V1 n° 18.

Question : Le nadolol et la mexilétine sont-ils autorisés ou importables en Suisse (spécialité, voie d'obtention), et quelles posologies du propranolol, du nadolol et de la mexilétine recommande la ligne directrice ESC 2022 (arythmies ventriculaires) dans le syndrome du QT long chez l'adulte et l'enfant ? Donnez la posologie selon l'information professionnelle suisse en vigueur (AIPS, swissmedicinfo.ch : spécialité ®, titulaire, date de révision, URL) : dose, voie, rythme, durée et adaptations rénale, hépatique, pédiatrique, grossesse et allaitement. Comparez avec la version citée dans le cours et signalez toute différence. À défaut d'IP suisse, citez la recommandation européenne la plus récente (titre, année, URL).

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

F-009 — Haute — LOT 247 · SSP O7.25

Emplacement : LOT_247_Appel_A_V5_Ultra_Pedagogique_Plan_et_Liste.html ; LOT_247_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_4_DX.8_a_DX.10.html › Bloc 1 › point 11.B › fluoropyrimidines et 11.C (DX.10) ; Partie 4 › DX.10 › points 9, 11.C, 11.D

Contexte : Le cours cite les réductions selon le score d'activité DPYD (1 : −50 % ; 1,5 : −25–50 % ; 0/0,5 : éviter) [S62], Xeloda®, Fluorouracil Accord® ; adaptations rénale/hépatique et calendrier biologique « donnée non trouvée » ; texte intégral SMW 2020 (DPYD Suisse) non lu.

Question : Quelles adaptations rénale et hépatique les IP suisses de Xeloda® et du 5-fluorouracile prévoient-elles, la Suisse impose-t-elle un génotypage ou un phénotypage DPD avant traitement (Swissmedic, recommandation suisse de pharmacogénomique SMW 2020 ou plus récente), et quel calendrier de surveillance (formule sanguine, toxicité, dosage du 5-FU) est recommandé chez le porteur ? Donnez la posologie selon l'information professionnelle suisse en vigueur (AIPS, swissmedicinfo.ch : spécialité ®, titulaire, date de révision, URL) : dose, voie, rythme, durée et adaptations rénale, hépatique, pédiatrique, grossesse et allaitement. Comparez avec la version citée dans le cours et signalez toute différence. À défaut d'IP suisse, citez la recommandation européenne la plus récente (titre, année, URL).

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :

4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

F-011 — Haute — LOT 247 · SSP O7.25

Emplacement : LOT_247_Appel_A_V5_Ultra_Pedagogique_Plan_et_Liste.html ; LOT_247_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_1_DX.1_a_DX.2.html › Bloc 1 › point 11.A (chirurgie prophylactique) et 11.C (DX.1) ; Partie 1 › DX.1 › points 11.A et 11.C

Contexte : Le cours cite NICE CG164 (IRM annuelle 30–49 ans, mammographie annuelle 40–69 ans) faute d'avoir lu le « Schéma de surveillance » OFSP (état 01/2021) ; âges d'annexectomie et surveillance de la prostate et du pancréas chez le porteur « donnée non trouvée » ; ESMO 2023 HBOC inaccessible. Questions pendantes HELP LOT_247 V1 n° 4, 5, 6.

Question : Quel est le contenu du « Schéma de surveillance » OFSP des porteuses BRCA1/2 (état 01/2021 ou plus récent) et de l'avis d'experts SSGO correspondant, quels âges d'annexectomie bilatérale prophylactique (BRCA1, BRCA2) et de mastectomie recommande ESMO 2023, et quelle surveillance de la prostate et du pancréas est recommandée chez le porteur masculin ou féminin ? Citez la recommandation suisse en vigueur (société savante ou autorité : titre, année, URL). Comparez sa version la plus récente avec celle utilisée dans le cours et listez les différences. Précisez les doses éventuelles selon l'information professionnelle suisse (AIPS). À défaut de source suisse, citez la recommandation européenne la plus récente.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

F-014 — Haute — LOT 247 · SSP O7.25

Emplacement : LOT_247_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_1_DX.1_a_DX.2.html › Partie 1 › DX.2 Lynch › points 3, 6, 7 (syndromes colorectal, gynécologique, autres localisations), 9 et fenêtre bio-mathématique 2.2

Contexte : Le cours renvoie aux recommandations EHTG/ESCP 2021 [S21] ; risques par gène et par localisation, Se/Sp du séquençage MMR, signe d'alerte gynécologique, risque colorectal de la population suisse, surveillance pendant la grossesse et imagerie de substitution : « donnée non trouvée ». Critère OPAS de coloscopie familiale cité.

Question : Quels risques cumulés de cancer (côlon, endomètre, ovaire, estomac, voies urinaires) par gène (MLH1, MSH2, MSH6, PMS2), quels intervalles de coloscopie et de surveillance gynécologique par gène, et quel risque colorectal de la population suisse donnent les recommandations européennes les plus récentes (EHTG/ESCP 2021 ou mise à jour, ESMO) ? Citez la recommandation suisse en vigueur (société savante ou autorité : titre, année, URL). Comparez sa version la plus récente avec celle utilisée dans le cours et listez les différences. Précisez les doses éventuelles selon l'information professionnelle suisse (AIPS). À défaut de source suisse, citez la recommandation européenne la plus récente.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

F-016 — Haute — LOT 247 · SSP O7.25

Emplacement : LOT_247_Appel_A_V5_Ultra_Pedagogique_Plan_et_Liste.html ; LOT_247_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_2_DX.3_a_DX.5.html › Bloc 1 › tableau de la conduite prénatale et tableau comparatif DX.3 ; Partie 2 › DX.3 › points 3, 9 (gold standard), fenêtre 3.2 ; Partie 3 › DX.6 › diagnostic prénatal

Contexte : Le cours cite le test combiné (≈ 90 %/5 %), le TPNI (T21 99,7 %/0,04 %), le seuil OPAS ≥ 1:1000 ; risque de fausse couche des gestes invasifs, prévalence de la T21 selon l'âge maternel, fréquence suisse du TPNI (« un quart des grossesses en 2019 » de presse), taux de discordance placentaire et Se/Sp du caryotype : « donnée non trouvée ». Avis d'experts SSGO n° 52 non lu. Questions pendantes HELP LOT_247 V1 n° 7, 8, 9, 10.

Question : Que dit l'avis d'experts SSGO sur le dépistage prénatal des aneuploïdies dans sa version la plus récente (n° 52 ou suivant), quel risque de fausse couche attribuable à la choriocentèse et à l'amniocentèse retient-il, quelle prévalence de la trisomie 21 selon l'âge maternel publient EUROCAT ou une source suisse, et quel est le taux suisse de recours au TPNI et de mosaïcisme placentaire confiné ? Citez la recommandation suisse en vigueur (société savante ou autorité : titre, année, URL). Comparez sa version la plus récente avec celle utilisée dans le cours et listez les différences. Précisez les doses éventuelles selon l'information professionnelle suisse (AIPS). À défaut de source suisse, citez la recommandation européenne la plus récente.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

F-018 — Haute — LOT 247 · SSP O7.25

Emplacement : LOT_247_Appel_A_V5_Ultra_Pedagogique_Plan_et_Liste.html ; LOT_247_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_2_DX.3_a_DX.5.html › Bloc 1 › point 8 et tableau « ce qui distingue » ; Partie 2 › DX.4 HF › points 8, 9, 11.C, 11.D et fenêtre forme homozygote

Contexte : Le cours cite la prévalence suisse 1:250 (< 10 % diagnostiqués) [S31], le score DLCN, l'étude CATCH ; différentiel des hypercholestérolémies secondaires, Se/Sp du test génétique, intervalle du bilan cardiovasculaire, gain par classe thérapeutique et survie : « donnée non trouvée ». ESC/EAS 2019 et mise à jour 2025 non lues en texte intégral (HELP V1 n° 5, 16).

Question : Quelles cibles de LDL-cholestérol, quelle séquence thérapeutique, quel bilan des causes secondaires (TSH, créatinine, albuminurie, tests hépatiques) et quel suivi recommandent pour l'HF la ligne directrice ESC/EAS 2019 et sa mise à jour ciblée 2025, et la recommandation suisse de la GSLA/SSC, avec les différences entre versions ? Citez la recommandation suisse en vigueur (société savante ou autorité : titre, année, URL). Comparez sa version la plus récente avec celle utilisée dans le cours et listez les différences. Précisez les doses éventuelles selon l'information professionnelle suisse (AIPS). À défaut de source suisse, citez la recommandation européenne la plus récente.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

F-019 — Haute — LOT 247 · SSP O7.25

Emplacement : LOT_247_Appel_A_V5_Ultra_Pedagogique_Plan_et_Liste.html ; LOT_247_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_2_DX.3_a_DX.5.html › Bloc 1 › fenêtre 8.1 (droit de prescrire) et tableau comparatif DX.5 ; Partie 2 › DX.5 hémochromatose › point 6 (base légale)

Contexte : Le cours cite l'OAGH art. 5 al. 1 (tout médecin peut prescrire les analyses diagnostiques hors maladies rares) ; le statut de « maladie rare » de l'hémochromatose HFE reste « non tranché ». Question pendante HELP LOT_247 V1 n° 17.

Question : L'hémochromatose HFE (homozygotie C282Y) est-elle une « maladie rare » au sens de l'OAGH art. 5 (liste, commentaire OFSP, Orphanet suisse), de sorte que le génotypage HFE et le test présymptomatique d'un apparenté soient ou non prescriptibles par tout médecin ? Citez le texte en vigueur (Fedlex : RS, article, alinéa et lettre exacts, état de consolidation, URL) ou l'entrée Swissmedic/AIPS ou la décision officielle, avec date. Comparez avec la version citée dans le cours et signalez tout changement.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

F-022 — Haute — LOT 247 · SSP O7.25

Emplacement : LOT_247_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_3_DX.6_a_DX.7.html ; LOT_247_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_4_DX.8_a_DX.10.html › Partie 3 › fenêtre transversale 5.3 (PMA/DPI) et prévention DX.7 ; Partie 4 › fenêtre transversale DPI et diagnostic prénatal (Huntington)

Contexte : Le cours cite la LPMA art. 5a al. 2 (maladie grave, début probable avant 50 ans, sans thérapie efficace) ; l'évaluation du critère « thérapie efficace » pour la mucoviscidose à l'ère des modulateurs et les modalités pratiques du DPI : « donnée non trouvée ».

Question : Comment l'OFSP, la Commission nationale d'éthique ou la jurisprudence interprètent-ils le critère « thérapie efficace » de la LPMA art. 5a pour la mucoviscidose traitée par modulateurs de CFTR, et quelles modalités (centres autorisés, délais, rapports OFS sur le DPI) s'appliquent au DPI en Suisse ? Citez le texte en vigueur (Fedlex : RS, article, alinéa et lettre exacts, état de consolidation, URL) ou l'entrée Swissmedic/AIPS ou la décision officielle, avec date. Comparez avec la version citée dans le cours et signalez tout changement.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

F-023 — Haute — LOT 247 · SSP O7.25

Emplacement : LOT_247_Appel_A_V5_Ultra_Pedagogique_Plan_et_Liste.html ; LOT_247_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_3_DX.6_a_DX.7.html › Bloc 1 › point 11.C (surveillance des apparentés CMH) ; Partie 3 › DX.7 › point 11.C

Contexte : Le cours écrit : intervalles de suivi des apparentés d'une cardiomyopathie hypertrophique selon l'ESC « donnée non trouvée » (ESC 2023 cardiomyopathies inaccessible). Question pendante HELP LOT_247 V1 n° 12.

Question : Quels intervalles de suivi clinique, ECG et échocardiographique des apparentés génotype positif/phénotype négatif et des apparentés non testés d'une CMH recommande la ligne directrice ESC 2023 sur les cardiomyopathies, selon l'âge ? Citez la recommandation suisse en vigueur (société savante ou autorité : titre, année, URL). Comparez sa version la plus récente avec celle utilisée dans le cours et listez les différences. Précisez les doses éventuelles selon l'information professionnelle suisse (AIPS). À défaut de source suisse, citez la recommandation européenne la plus récente.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

F-024 — Haute — LOT 247 · SSP O7.25

Emplacement : LOT_247_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_3_DX.6_a_DX.7.html › Partie 3 › DX.7 › point 4, fenêtres syndromes 7.3 (Brugada) et 7.4 (TVPC), tableau des critères, point 8

Contexte : Le cours cite seulement SCN5A et l'effet de la flécaïnide [S52] ; prévalence, critères diagnostiques, test provocateur et prise en charge du syndrome de Brugada, de la TVPC et de la cardiomyopathie arythmogène, ainsi que les causes non cardiaques qui miment un événement rythmique : « donnée non trouvée ».

Question : Quels critères diagnostiques, quels tests provocateurs (ajmaline ou flécaïnide, épreuve d'effort), quels gènes, quelle prévalence et quels traitements (bêtabloquant, flécaïnide, DAI, quinidine) recommande la ligne directrice ESC 2022 pour le syndrome de Brugada et la TVPC, et quels critères (Padoue/Task Force) l'ESC 2023 retient-elle pour la cardiomyopathie arythmogène ? Citez la recommandation suisse en vigueur (société savante ou autorité : titre, année, URL). Comparez sa version la plus récente avec celle utilisée dans le cours et listez les différences. Précisez les doses éventuelles selon l'information professionnelle suisse (AIPS). À défaut de source suisse, citez la recommandation européenne la plus récente.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

F-025 — Haute — LOT 247 · SSP O7.25

Emplacement : LOT_247_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_3_DX.6_a_DX.7.html › Partie 3 › DX.7 › fenêtre bio-mathématique QTc (Bazett/Fridericia)

Contexte : Le cours montre qu'à 75 bpm, Bazett donne 492 ms et Fridericia 474 ms ; la formule de correction de l'ESC 2022 et les seuils masculin/féminin complets : « donnée non trouvée ».

Question : Quels seuils de QTc (homme, femme, enfant) et quel score (Schwartz) l'ESC 2022 retient-elle pour diagnostiquer le syndrome du QT long, et quelle formule de correction recommande-t-elle selon la fréquence cardiaque ? Donnez la valeur seuil validée, la population de validation (suisse ou germanophone/francophone si possible), la sensibilité et la spécificité, avec la source primaire (titre, année, URL). Signalez toute recommandation suisse ou européenne qui adopte ce seuil.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :

2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

F-027 — Haute — LOT 247 · SSP O7.25

Emplacement : LOT_247_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_4_DX.8_a_DX.10.html › Partie 4 › DX.8 X fragile › tableau du risque d'expansion (mère prémutée de 56 CGG)

Contexte : Le cours écrit : probabilité d'expansion vers une mutation complète pour une prémutation maternelle de 56 CGG « non chiffrée » ; il renvoie au généticien.

Question : Quel risque d'expansion vers une mutation complète selon la taille de la prémutation maternelle (55–59, 60–69, 70–79, 80–89, ≥ 90 CGG) et selon les interruptions AGG donnent les recommandations EMQN ou une source européenne de référence ? Donnez la valeur seuil validée, la population de validation (suisse ou germanophone/francophone si possible), la sensibilité et la spécificité, avec la source primaire (titre, année, URL). Signalez toute recommandation suisse ou européenne qui adopte ce seuil.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

F-030 — Haute — LOT 247 · SSP O7.25

Emplacement : LOT_247_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_4_DX.8_a_DX.10.html › Partie 4 › fenêtre transversale assurances (LAGH, seuils 400 000 CHF et 40 000 CHF) › piège d'examen

Contexte : Le cours cite les seuils de 400 000 CHF (assurance vie) et 40 000 CHF (invalidité) ; la question des antécédents familiaux déclarés, non couverts par ces articles, reste « donnée non trouvée ».

Question : Un assureur privé peut-il, selon la LAGH (art. 43–44) et la doctrine ou la jurisprudence suisse, exiger la déclaration d'antécédents familiaux d'une maladie héréditaire ou le résultat d'un test présymptomatique d'un apparenté, et quelles sont les exceptions exactes ? Citez le texte en vigueur (Fedlex : RS, article, alinéa et lettre exacts, état de consolidation, URL) ou l'entrée Swissmedic/AIPS ou la décision officielle, avec date. Comparez avec la version citée dans le cours et signalez tout changement.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

FIN DU PAQUET HELP_Organi_P29 — 19 questions : F-135, F-001, F-002, F-003, F-004, F-005, F-007, F-009, F-011, F-014, F-016, F-018, F-019, F-022, F-023, F-024, F-025, F-027, F-030